

Razonamiento clínico — Cuello

bodyPart: neck · entry: nk_master_entry

Árbol interactivo de razonamiento clínico (Physioguide / AIKinora). Uso educativo para fisioterapeutas. No sustituye valoración presencial.

Nodos totales: 8

Entrada alternativa por test del informe

- **spurling** → nk_spurling
- **ultt** → nk_ultt

Flujo de nodos (desde la entrada)

1. [CONCLUSIÓN] Cuello — árbol maestro Physioguide

id: nk_master_entry

Resumen: Flujo: red flags/trauma (C-spine) → ¿radicular vs mecánico? → cluster Wainner → diferencial hombro. Nunca Spurling = hernia confirmada.

Hipótesis:

- **Enrutar por seguridad y patrón radicular vs local** (alta) — Trauma → imagen. Brazo/hormigueo → Wainner. Solo cuello → mecánico.
- Continúa en: **nk_trauma_gate**

2. [TEST / GATE] ¿Trauma cervical o red flag urgente?

id: nk_trauma_gate

testId: route-neck-trauma

Descripción: Trauma mayor → C-spine/NEXUS (no Spurling). Mielopatía, disección o meningismo → urgencias.

Procedimiento: Enrutado de seguridad.

- **Positivo / Sí:** Trauma mayor / inestable / mielopatía / disección → **nk_trauma_cluster**
- **Negativo / No:** Estable — sin RF de trauma → **nk_radicular_gate**

3. [CONCLUSIÓN] Priorizar imagen / urgencias — no tests provocativos

id: nk_trauma_cluster

Resumen: Trauma no bajo riesgo, mielopatía, disección o meningismo. Canadian C-spine/NEXUS. No Spurling.

Hipótesis:

- **Trauma cervical / RF — valoración urgente** (alta) — Seguridad antes que cluster radicular.
- Nodo terminal (fin de rama).

4. [TEST / GATE] ¿Síntomas en brazo o solo cuello?

id: nk_radicular_gate

testId: route-neck-radicular

Descripción: Irradiación/hormigueo → cluster Wainner. Solo local → cervicalgia mecánica.

Procedimiento: Enrutado clínico.

- **Positivo / Sí:** Brazo / hormigueo / patrón radicular → **nk_radiculopathy_cluster**
- **Negativo / No:** Dolor local de cuello → **nk_mechanical_cluster**

5. [CONCLUSIÓN] Compatible con radiculopatía cervical

id: nk_radiculopathy_cluster

Resumen: Cluster Wainner (ULTT + Spurling + distracción + rotación <60°). Spurling negativo no excluye. No inventar nivel de raíz ni hernia confirmada.

Hipótesis:

- **Radiculopatía cervical** (alta) — Patrón brazo + provocación cervical.
 - **RCRSP / hombro coexistente** (media) — Si dolor anterolateral sin neural claro.
- Continúa en: **nk_spurling**

6. [CONCLUSIÓN] Compatible con cervicalgia mecánica

id: nk_mechanical_cluster

Resumen: Dolor local + movimiento mecánico + neural no familiar. No forzar hernia.

Hipótesis:

- **Cervicalgia mecánica / sobrecarga** (alta) — Sin cluster radicular.
 - **Cefalea cervicogénica** (media) — Nuca → sien/ojo relacionada con cuello.
- Continúa en: **nk_ultt**

7. [TEST / GATE] Test de Spurling

id: nk_spurling

testId: spurling

Descripción: Extensión + inclinación + compresión axial cervical hacia el lado sintomático.

Procedimiento: Extensión + inclinación + compresión axial cervical hacia el lado sintomático.

Evidencia: Tong/Wainner: más específico que sensible para radiculopatía. Negativo no excluye cuello. No es test de manguito.

- **Positivo / Sí:** Reproduce dolor/hormigueo de brazo familiar → **nk_radiculopathy_cluster**
- **Negativo / No:** Spurling no familiar / solo cuello → **nk_ultt**

8. [TEST / GATE] ULTT / ULNT

id: nk_ultt

testId: ultt

Descripción: Tensión neural del mediano (depression-humeral, extensión codo/muñeca/dedos).

Procedimiento: Tensión neural del mediano (depression-humeral, extensión codo/muñeca/dedos).

Evidencia: Wainner Spine 2003: sensible, poco específico aislado. Cluster con Spurling/distracción. Tirantez ≠ hernia ni túnel carpiano.

- **Positivo / Sí:** Reproduce síntomas familiares de brazo → **nk_radiculopathy_cluster**
- **Negativo / No:** Solo tirantez inespecífica → **nk_mechanical_cluster**